Министерство здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова

Медицинская Лига России

Всероссийская
научно-практическая
междисциплинарная конференция
с международным участием

«РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА–2014»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

16–17 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

МОСКВА

Издательство Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва 2014

УДК 616.8
ББК 56.12
Р31

Р31 Реабилитация и профилактика-2014 // Сборник материалов научной конференции. – М.: Издательство Первого московского государственного университета имени И.М. Сеченова. – 2014. – 234 с/

Все материалы в сборнике приведены в авторской редакции.
Издание сборника при поддержке РФФИ.

© ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, 2014
© Издательство Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 2014

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ СТУДЕНТОК - 200 -
В.О. Третьяков, П.А. Шишкин, Ю.Л. Веневцева
ФИТОПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ СОСУДОВ: НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ - 200 -
С.Н. Турищев
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С НЕЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ В АНАМНЕЗЕ - 201 -
Н.Г. Туровская
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ РИСКЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА - 204 -
Е.В. Фадеева, И.А. Геронимус, О.В. Цветкова
ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ОРГАНИЗОВАННОГО НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ПОЛУФАБРИКАТЫ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ - 204 -
Е.Ю. Федичева, Е.Ю. Козина
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТОКСИКОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ САНИТАРНЫХ ВРАЧЕЙ - 205 -
А.С. Филин, М.М. Мехова
ХРОНИЧЕСКИЕ ПСИХОГЕННЫЕ ДОРСАЛГИИ. ДИАГНОСТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ - 206 -
В.А. Фролов, В.С. Кононова
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ХАОСА-САМООРГАНИЗАЦИИ - 209 -
А.А. Хадарцев, В.М. Еськов, В.Г. Зилов, О.Е. Филатова, В.В. Еськов
РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ - 210 -
М.А. Хан, О.В. Подгорная, М.Р. Макарова, Н.И. Тарасов, Л.Ю. Даринская, А.Н. Хромов, И.С. Кириллова
ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ - 210 -
Т.В. Хамина, Г.Р. Кривцова
ДЕТЕРМИНАНТЫ ТАБАКОКУРЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ - 211 -
О.А. Харькова, А.Г. Соловьев
НОВОЕ В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ К ГИПОКСИИ/«ГИПОКСИЧЕСКИЙ ФИТНЕСС+» - 211 -
А.М. Цветкова, В.А. Парамонов
РЕАБИЛИТАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ - 212 -
Е.В. Чемоданова
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ТОНУСА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ - 212 -
Л.Ф. Чепурная, Н.С. Григорьева
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ - 213 -
Л.Ф. Чепурная
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ - 214 -
Д.С. Черемисина
МЕТОД МОНИТОРИНГА КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ АОРТЫ В ДИАСТОЛИЧЕСКИХ ФАЗАХ СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА - 215 -
Н.Н. Чернов, Д.Ф. Македонский
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО МЕТОДУ Р.ФОЛЛЯ У ПАЦИЕНТОВ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ - 216 -
А.В. Черногорцев, Е.Б. Новикова
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕПЕРНОГО ПРИНЦИПА И ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ - 216 -
И.М. Черныш
РОЛЬ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - 217 -
С.В. Чечиль
РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА, РАЗРАБОТАННОЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ АКАДЕМИКА П.К.АНОХИНА - 219 -
Д.А. Шаменков, А.Ю. Ульянин, К.В. Судаков
ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА РАЗНЫХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ - 221 -
Е.Ю. Шаламова, В.Р. Сафонова, О.Н. Рагозин
РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ WINDOWS STORE - 223 -
С.А. Шевцов, Н.Н. Музалёв
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ДЕПРЕССИЙ ПРИ ДОРСОПАТИЯХ - 224 -
С.А. Шевцов, Л.В. Смекалкина, С.А. Божко, Т.П. Рязанцева, А.В. Новиков

1. Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений. Избранные психологические труды //Под ред. В.П. Зинченко 2-е изд., - М.: «МОДЭК», - 2004. – 688с.
2. Сафоничева О.Г., Хадарцев А.А., Еськов В.М., Кидалов В.Н. Теория и практика восстановительной медицины. Сер. Мануальная диагностика и терапия. Москва – «ИНФА», - 2006. – 151с.
3. Сафоничева О.Г. Восстановительное лечение опорно-двигательной системы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук/ Тульский государственный университет. Тула, 2007.
4. Саморуков А.Е., Будылин С.П. Новые технологии мануальной терапии в коррекции сомато-висцеральных дисфункций. Актуальные вопросы восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии» // Материалы Межд. Конгресса «Здравница - 2002». М. -2002. – С.184.

РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА, РАЗРАБОТАННОЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ АКАДЕМИКА П.К. АНОХИНА

Д.А. Шаменков, А.Ю. Ульянин, К.В. Судаков
Фонд Сколково, Москва, Россия
*Школа «*Система управления здоровьем*», Москва, Россия*
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМ, Москва, Россия
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Данная работа посвящается нашему Учителю, академику РАМН К.В.Судакову, чьи идеи легли в основу «Системы управления здоровьем».

Цель настоящей работы. Исследование влияния инновационной системы управления здоровьем человека, разработанной на основе теории функциональных систем академика П.К.Анохина, (далее, - Система управления здоровьем, СУЗ) на качество жизни человека.

Настоящее исследование проводилось в ходе онлайн-тренинга «Синхронизация 1.0» Школы «Система управления здоровьем», который проходил с 9 апреля по 9 мая 2014 года. В тренинге приняли участие 163 человека, средний возраст - 39 лет, 8 месяцев, 60% - женщины.

Цель тренинга - обучение участников инновационной Системе управления здоровьем, получение участниками практического опыта применения СУЗ в повседневной деятельности для улучшения здоровья и качества жизни. В ходе тренинга использованы современные информационно-коммуникационные технологии (социальные сети и интерактивные онлайн-семинары - вебинары). Сообщество участников тренинга, включая родственников участников, тренера и его помощников, представляет из себя системную организацию - функциональную систему, системообразующим фактором в которой служит результат по достижению участниками высокого качества жизни.

Как мы писали ранее (Шаменков Д.А., Судаков К.В., 2013), в такой социально организованной функциональной системе, наряду с индивидуальным представительством каждого пользователя, формируется обобщенный социально значимый информационный акцептор результата действия, строящийся на компьютерной социальной сети. Данная системная организация направлена на получение знаний о собственном здоровье и здоровье пользователей со сходным профилем эмоционально-личностных качеств, заболеваний и стремлений. Это создает условия для взаимосодействия людей по сходным программам действий и коллективного обогащения как объединенного аппарата акцептора результатов действий, так и индивидуальных акцепторов результатов действий у отдельных пациентов.

В системе предусмотрено участие тренера, прошедшего специальное обучение, который организует обратную связь, вносит в систему необходимые руководства, используемые в дальнейшем другими участниками системы.

Деятельность пользователей в системе приводит к удовлетворению их потребности в получении информации, к формированию на этой основе программ действий для повышения качества жизни и реализации созданных программ.

Конечным результатом деятельности системы является улучшение соматического и психоэмоционального состояния пациентов, повышение уровня общественного здоровья популяции, объединенной в предлагаемую функциональную систему.

Предлагаются следующие принципиальные положения модели общественной функциональной системы на основе теории функциональных систем:

Социальная система управления здоровьем строится на основе принципа иерархии функциональных систем.

Создание общественной функциональной системы управления здоровьем с обобщенным в ней информационным акцептором результата действия происходит благодаря результативному взаимодействию пользователей системы, основанному на личностных мотивациях.

Обратное влияние предлагаемой модели и, главным образом, обобщенного информационного акцептора результата действия приводит к повышению результативности функциональной системы за счет обмена информацией между пользователями.

Формат тренинга:

За несколько дней до старта тренинга участники получили материалы с подробным описанием ключевых упражнений Системы управления здоровьем, их научно-популярным обоснованием. В первый день тренинга проведен вводный онлайн-семинар (вебинар), в ходе которого тренер повторил общие принципы СУЗ, сделал подробное описание и научное объяснение (в научно-популярной форме) ключевых упражнений СУЗ, подробно ответил на вопросы участников.

В течение 30 дней участники тренинга формировали динамический стереотип управления здоровьем через регулярное повторение упражнений СУЗ, обменивались опытом практики в закрытой группе в социальной сети Facebook. Каждое утро все желающие собирались в интерактивной вебинарной комнате на групповое упражнение, нацеленное на развитие осознанности («Практика молчания СУЗ») (Шаменков Д.А., 2009; Kabat-Zinn J., 1982, 1985, 1988, 1992, 1995, 2003, 2008, 2013; Bradley R., 2013; Barker KK., 2014).

Каждую неделю участники с тренером собирались в интерактивной вебинарной комнате для обсуждения хода практики и получения ответов на накопившиеся вопросы (всего - 8 вебинаров, 2 раза в неделю). После каждого проведенного вебинара участникам предоставлялась запись, к которой можно было получить доступ на протяжении тренинга.

Перед началом тренинга, сразу после его окончания участники проходили исследование качества жизни. Во всех трех измерениях приняли участие 55 человек.

Метод. Исследование влияния Системы управления здоровьем на качество жизни проводили с использованием опросника Всемирной организации здравоохранения для определения качества жизни (ВОЗКЖ-100). Опросник ВОЗКЖ-100 разработан ВОЗ с целью получения качественного и независимого инструмента оценки качества жизни людей вне зависимости от социального, культурного, демографического и политического контекста.

Качество жизни, связанное со здоровьем, можно рассматривать как интегральную характеристику оценки человеком своего физического, психического и социального функционирования.

100 вопросов ВОЗКЖ позволяют оценить качество жизни в 6 сферах жизни человека: физическая сфера, психологическая сфера, независимость, социальная активность, окружающая среда и духовность. Кроме того, 4 вопроса оценивают качество жизни в целом.

ВОЗКЖ-100 является многомерным инструментом, позволяющим получить как оценку качества жизни респондента в целом, так и частные оценки по отдельным сферам и субсферам жизни. При этом он дает не только общую меру, но и целый профиль качества жизни, позволяя проводить многомерный анализ.

Полученные результаты. Результаты исходного исследования: физическая сфера 13,70 (m±0,35, m - стандартная ошибка среднего, n=55), психологическая сфера 13,87 (m±0,36), уровень независимости 16,64 (m±0,26), социальные взаимоотношения 13,70 (m±0,34), окружающая среда 14,72 (m±0,28), духовная сфера 16,69 (m±0,39), суммарная оценка 89,32 (m±1,52).

Результаты заключительного исследования (через 4 недели после начала тренинга): физическая сфера 16,30 (+18.97%) (m±0,30), психологическая сфера 16,08 (+15.9%) (m±0,30), уровень независимости 18,19 (+9.3%) (m±0,21), социальные взаимоотношения 15,45 (+12.7%) (m±0,33), окружающая среда 16,67 (+13.2%) (m±0,27), духовная сфера 17,79 (+6.6%) (m±0,28), суммарная оценка 100,59 (+12.6%) (m±1,35).

По результатам исходного исследования можно выделить две группы участников - группа №1 - с исходно низким суммарным показателем здоровья (ниже среднего значения по группе 89.32) - 26 человек, и группа №2 - с исходно высоким суммарным показателем здоровья (выше среднего значения по группе) - 29 человек.

Результаты исходного исследования группы №1 (m - стандартная ошибка среднего, n=26): физическая сфера 12,04 (m±0.40), психологическая сфера 11,88 (m±0,46), уровень независимости 15,53 (m±0,34), социальные взаимоотношения 12,06 (m±0,42), окружающая среда 13,31 (m±0,37), духовная сфера 14,85 (m±0,59), суммарная оценка 79,67 (m±1,68).

Результаты заключительного исследования группы №1 (через 4 недели после начала тренинга): физическая сфера 15,28 (+26,94%) (m±0,50), психологическая сфера 14,89 (+25,31%) (m±0,47), уровень независимости 17,41 (+12,14%) (m±0,35), социальные взаимоотношения 14,24 (+18,07%) (m±0,48), окружающая среда 15,58 (+17,05%) (m±0,39), духовная сфера 17,15 (+15,54%) (m±0,49), суммарная оценка 94,57 (+18,69%) (m±2,08).

Результаты исходного исследования группы №2 (m - стандартная ошибка среднего, n=29): физическая сфера 15,18 (m±0,40), психологическая сфера 15,66 (m±0,26), уровень независимости 17,63 (m±0,28), социальные взаимоотношения 15,17 (m±0,36), окружающая среда 15,99 (m±0,25), духовная сфера 18,34 (m±0,29), суммарная оценка 97,97 (m±0,84).

Результаты заключительного исследования группы №2 (через 4 недели после начала тренинга): физическая сфера 17,22 (+13,4%) (m±0,28), психологическая сфера 17,15 (+9,56%) (m±0,28), уровень независимости 18,89 (+7,14%) (m±0,16), социальные взаимоотношения 16,54 (+9,02%) (m±0,36), окружающая среда 17,64 (+10,35%) (m±0,28), духовная сфера 18,55 (+1,13%) (m±0,28), суммарная оценка 105,99 (+8,19%) (m±1,05).

Выводы. Применение современных информационно-коммуникационных и образовательных технологий на основе теории функциональных систем П.К.Анохина позволило создать эффективную систему для сохранения здоровья людей. СУЗ может быть применимым и потенциально эффективным методом улучшения качества жизни среди людей, испытывающих в этом потребность.

СУЗ особенно эффективна в группе пациентов с исходно низким уровнем качества жизни (ниже 89.32). Наибольшее улучшение качества жизни показано в физической сфере (+26,94%), психологической сфере (+25,31%) и социальных взаимоотношениях (+18,07%), в суммарной оценке (+18,69%).

Направления дальнейшего изучения СУЗ: проведение дополнительных исследований участников тренинга через 3 месяца, 1 год и 3 года после окончания тренинга, разработка рандомизированных клинических исследований применения СУЗ в группах участников, имеющих различные заболевания.